Anexo técnico de integración — actualización de la PC2

Grupo 10 UNI: Santa Cruz Basilio, Jesus Diego — 20235005G; López Arteaga, César Omar — 20236743A; Pumayauli Evangelista, Bryan José — 20212209E.

Alcance del anexo

Este anexo complementa el informe original 01-informe-PC2.docx y su PDF. No atribuye aportes individuales sin evidencia. Se mantiene el título original TriageVoz Rural, pero se describe el alcance actual después de integrar silueta corporal frontal/posterior, personalización adaptativa, historial médico simulado y bandeja de casos.

A. Implementación realmente disponible

1. PWA: interfaz HTML/CSS/JS adaptable, manifiesto y Service Worker.
2. Interacción multimodal: región anatómica por silueta SVG, texto y dictado opcional.
3. Perfil adaptativo: preferencias persistentes, ritmo de respuesta y ayudas de corrección.
4. Entrevista: cuatro preguntas, confirmación y edición.
5. Resumen: fallback local; Gemini solo cuando el servidor tiene clave y conexión.
6. Bandeja: registros de casos ficticios que pueden consultarse con un segundo rol en el mismo servidor local; sin videollamada, sesión simultánea o login.
7. Acuse y respuestas: estado enviado/recibido y respuestas persistidas, consultables por el paciente. Los reintentos idénticos no duplican la última respuesta.
8. Persistencia: JSON serializado y caso reciente recuperable al recargar el navegador.

B. Diferencia frente al enunciado y trabajos LEC06/LEC07

La solución preserva los requerimientos iniciales como objetivos de diseño, pero no implica que todos estén implementados plenamente. El multiusuario es una simulación de roles locales. Las funciones de priorización sanitaria, traducción quechua real, privacidad clínica, despliegue interdispositivos y videollamada son trabajo futuro. No se inventan resultados de evaluación de usabilidad ni se confunden con pruebas automatizadas.

C. Evaluación de integración

Se amplió la suite a 12 pruebas automáticas que incluyen 8 solicitudes concurrentes, duplicados de respuesta, conservación del acuse, bandeja y errores HTTP. La evaluación clínica y las pruebas con usuarios voluntarios siguen pendientes.

D. Evidencias

Las capturas anteriores siguen archivadas como históricas. Para la presentación final se recomienda grabar o capturar nuevamente la interfaz vigente mediante el procedimiento del archivo 06-pruebas-y-evidencias.md.

Carácter del documento: apéndice de actualización, sin sustituir las fuentes originales de LEC06, LEC07 o el enunciado de la PC2.